



Refluxo Gastroesofágico: Guia de Revisão

Conceitos essenciais, diagnóstico, tratamento e complicações

Material produzido pela LAGEN — Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia

Este material reúne, de forma objetiva, os pontos mais importantes sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), um dos temas mais frequentes em avaliações de Gastroenterologia. A ideia é organizar o raciocínio clínico desde o reconhecimento dos sintomas até a investigação, o tratamento e o acompanhamento das complicações, com destaque para o esôfago de Barrett.

1. O que é a DRGE?

Trata-se de uma condição crônica caracterizada pelo retorno do conteúdo do estômago em direção ao esôfago, decorrente de uma falha no fechamento do esfíncter esofágico inferior (EEI) — estrutura que sofre relaxamentos inadequados fora dos momentos de deglutição. Na maior parte das vezes (80 a 90%), o material refluído é ácido; em uma parcela menor (10 a 20%), o refluxo envolve bile ou enzimas pancreáticas, sendo classificado como não ácido.

É importante lembrar que refluxos ocasionais fazem parte da fisiologia normal. Para que se configure doença, é necessário que os episódios sejam recorrentes — pelo menos um por semana, mantidos por mais de quatro semanas — ou que haja dano visível à mucosa esofágica, como esofagite, estenose ou metaplasia.

1.1 Quadro clínico

Os sintomas clássicos são a **pirose** (queimação retroesternal, o mais frequente) e a **regurgitação** do conteúdo alimentar (o segundo mais comum). Juntos, apresentam sensibilidade diagnóstica de 60 a 70% e costumam responder bem ao tratamento empírico com inibidores de bomba de prótons.

Além do quadro típico, até 30% dos pacientes podem apresentar manifestações atípicas, resultantes da ação do ácido fora do esôfago ou de reflexos neurais: tosse seca persistente, pigarro, rouquidão, otite, faringite, laringite, crises de asma, pneumonias de repetição e dor torácica de origem não cardíaca. Esses sintomas têm sensibilidade diagnóstica baixa (em torno de 20%) e resposta mais irregular à terapia empírica, exigindo documentação por exames complementares e exclusão de outras causas.

1.2 Fatores associados

Diversas condições favorecem o aparecimento ou a piora da DRGE, entre elas:

- Obesidade;
- Uso de determinados medicamentos (bloqueadores de canal de cálcio, diazepam, anticolinérgicos, ácido acetilsalicílico, teofilina, progesterona);
- Esclerodermia;

- Gastroparesia;
- Hérnia hiatal por deslizamento (tipo I), que alarga o hiato diafragmático;
- Tabagismo.

2. Como conduzir o caso conforme a idade e os sinais de alarme

A estratégia inicial diante de uma suspeita de DRGE depende basicamente de dois fatores: a idade do paciente e a presença ou não de sinais de alarme (emagrecimento, anemia, sangramento digestivo ou disfagia).

Pacientes com menos de 50 anos e sem sinais de alarme

Nesse grupo, o diagnóstico pode ser puramente clínico. Institui-se tratamento empírico com um inibidor de bomba de prótons (omeprazol, pantoprazol ou esomeprazol são exemplos), administrado em jejum, cerca de 30 a 60 minutos antes do café da manhã, por um período de 6 a 8 semanas. Paralelamente, recomendam-se mudanças de estilo de vida: emagrecimento, cessação do tabagismo, fracionamento das refeições a cada 3 horas, redução de frituras e gorduras, e elevação da cabeceira da cama. Caso não haja resposta satisfatória, a dose do IBP pode ser dobrada, passando a duas tomadas diárias.

Atenção: os bloqueadores H2 (ranitidina, cimetidina, famotidina, nizatidina) são menos eficazes que os IBPs tanto para alívio sintomático quanto para cicatrização da mucosa, sendo reservados como segunda linha — em casos de intolerância aos IBPs ou durante o desmame. Já os procinéticos (domperidona, metoclopramida) não têm papel no tratamento padrão da DRGE; seu uso fica restrito a pacientes que também apresentam sintomas de gastroparesia (plenitude pós-prandial, saciedade precoce, náuseas), quadro que pode agravar o refluxo.

Pacientes com mais de 50 anos, com sinais de alarme ou refratários ao tratamento inicial

Esse grupo deve ser investigado com exames complementares. A investigação adicional está indicada em três cenários principais:

- Idade acima de 50 anos, pelo maior risco de complicações como esofagite ou esôfago de Barrett;
- Presença de sinais de alarme, que exigem afastar diagnósticos diferenciais, sobretudo neoplasia esofágica;
- Ausência de resposta ao tratamento com IBP em dose otimizada.

3. Exames complementares na DRGE

Vale reforçar: pacientes jovens, com sintomatologia típica e boa resposta ao IBP, dispensam qualquer exame adicional. Quando a investigação é necessária, a sequência lógica costuma ser a seguinte:

Exame	Papel na investigação
Endoscopia digestiva alta (EDA)	Costuma ser o primeiro exame solicitado. Não confirma o refluxo em si, mas tem alta especificidade para identificar lesões da mucosa (esofagite, estenose, Barrett) e para descartar diagnósticos diferenciais, como câncer de esôfago. O diagnóstico de esôfago de Barrett exige biópsia da área suspeita.
pHmetria de 24 horas	Considerada o padrão-ouro para confirmar a doença, pois documenta os episódios de refluxo ácido ($\text{pH} < 4$) e os correlaciona aos sintomas relatados. É reservada para casos de dúvida diagnóstica, refratariedade ou avaliação pré-operatória. Limitação: não detecta cerca de 10 a 20% dos refluxos, justamente os de natureza não ácida.
Impedância-pHmetria	Exame mais sensível, capaz de identificar tanto refluxos ácidos quanto não ácidos. É indicado quando a suspeita clínica é alta e a pHmetria convencional resulta normal. Ainda pouco disponível na maioria dos serviços.
Manometria esofágica	Não estabelece o diagnóstico de DRGE. Suas finalidades são: excluir distúrbios motores (como a acalasia) em pacientes com disfagia; avaliação pré-operatória antes de cirurgia antirrefluxo; e localização do EEI durante a realização da pHmetria.
Cintilografia	Método utilizado principalmente para avaliação de refluxo em crianças.
Esofagografia baritada	Reservada para avaliação de alterações estruturais: anéis, membranas, estenoses, dilatações e hérnias hiatais.

3.1 Classificando a esofagite à endoscopia

A classificação endoscópica mais utilizada na prática — e mais cobrada em provas — é a de Los Angeles, que graduada a gravidade das erosões esofágicas:

Grau	Achado endoscópico
A	Erosões menores que 5 mm, restritas a pregas isoladas.
B	Erosões maiores que 5 mm, ainda em pregas isoladas.
C	Erosões confluentes entre pregas, comprometendo menos de 75% da circunferência esofágica.
D	Erosões confluentes, ocupando mais de 75% da circunferência.

Uma classificação alternativa, mais detalhada, é a de Savary-Miller. O ponto-chave a memorizar é que o grau IV corresponde a lesões crônicas (úlcera, subestenose ou esôfago curto) e o grau V já indica a presença de esôfago de Barrett.

Grau	Características
I	Erosão única, com ou sem fibrina, em uma única prega longitudinal.
II	Erosões lineares em mais de uma prega, com ou sem confluência.

Grau	Características
III	Erosões confluentes de aspecto circular, ocupando toda a circunferência, com exsudato.
IV	Lesões crônicas: úlcera, subestenose ou esôfago curto, isoladas ou associadas aos graus I a III.
V	Esôfago de Barrett, associado ou não a lesões dos graus I a IV.

Um dado relevante: mesmo em pacientes sintomáticos, a EDA pode ser completamente normal em até 60% dos casos — o que caracteriza a chamada DRGE não erosiva. Nessa situação, persistindo a dúvida diagnóstica, avança-se para a pHmetria de 24 horas.

4. Quando considerar cirurgia

A cirurgia antirrefluxo entra em cena em situações específicas, e não como conduta de rotina. As principais indicações são:

- Falha do tratamento clínico bem conduzido;
- Desejo do paciente de interromper a terapia farmacológica crônica;
- Má adesão ou intolerância aos efeitos colaterais da medicação;
- Sintomas respiratórios persistentes (asma, broncoaspiração) com refluxo patológico documentado como causa provável;
- Esofagite grave (graus C ou D) ou estenose péptica refratárias ao tratamento medicamentoso;
- Esôfago de Barrett associado a sintomas refratários (o tratamento cirúrgico do Barrett assintomático ainda é controverso).

Antes de operar, a manometria esofágica é indicada para descartar distúrbios motores que possam contraindicar a técnica cirúrgica escolhida. Pacientes que respondem bem aos IBPs tendem a responder melhor também à cirurgia, já que isso comprova que a supressão ácida controla os sintomas. As técnicas mais empregadas são a funduplicatura total a 360° (cirurgia de Nissen) e as funduplicaturas parciais (Toupet, a 270°; Guarner, a 240°; ou Dor, a 180°).

5. Complicações da DRGE

A doença pode evoluir com três complicações principais: esofagite, estenose péptica e esôfago de Barrett.

A **esofagite** (erosões ou úlceras na mucosa esofágica) é a complicação mais frequente na prática clínica, embora seja pouco explorada em provas. Costuma responder bem ao IBP, com cicatrização em mais de 90% dos casos.

A **estenose péptica** é mais rara e geralmente resulta de uma esofagite grave não tratada adequadamente, que evolui com retração cicatricial e redução do calibre esofágico. Manifesta-se tipicamente como disfagia progressiva para sólidos em paciente com DRGE crônica — um sinal de alarme que impõe a realização de EDA para afastar neoplasia. Confirmada a estenose, o tratamento pode ser a dilatação endoscópica com balão ou, nos casos refratários, a ressecção cirúrgica.

5.1 Esôfago de Barrett

É a complicação mais cobrada em avaliações e consiste na substituição do epitélio escamoso típico do esôfago por um epitélio colunar (glandular) rico em células caliciformes — um processo chamado de metaplasia intestinal. Os principais fatores de risco são idade acima de 50 anos, obesidade, sexo masculino, etnia branca, tabagismo e sintomas de refluxo mal controlados por mais de cinco anos.

Todo paciente com mais de 50 anos e DRGE crônica deve realizar EDA, já que esse é o único método capaz de rastrear a condição. O achado endoscópico típico consiste em projeções digitiformes ou circulares, de coloração alaranjada ou salmão, partindo da transição esofagogástrica. A confirmação depende de biópsia, que revela epitélio colunar com células caliciformes, coradas pelo azul-alciano.

O grande risco do esôfago de Barrett é a progressão para adenocarcinoma esofágico distal, risco que só se torna relevante quando surgem displasias (alterações glandulares com perda da arquitetura normal). Sem displasia, a incidência anual de câncer é baixa (cerca de 0,12%); com displasia, esse risco pode ser de 40 a 90 vezes maior que o da população geral.

Como nenhum tratamento — medicamentoso ou cirúrgico — reverte a metaplasia já estabelecida, todo paciente diagnosticado entra em protocolo de vigilância endoscópica periódica. A conduta varia conforme o grau de displasia encontrado:

Situação	Conduta recomendada
Sem displasia	Inibidor de bomba de prótons; vigilância endoscópica a cada 3 a 5 anos.
Displasia de baixo grau	Otimizar dose de IBP e repetir EDA com biópsia em 3 a 6 meses. Se a displasia for confirmada: erradicar o epitélio por ablação por radiofrequência (RFA).
Displasia de alto grau	Erradicação imediata do epitélio metaplásico, por RFA ou, quando indisponível, por esofagectomia distal — dado o altíssimo risco de progressão para câncer em curto prazo.

Material produzido pela LAGEN — Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia — para fins de estudo e revisão do tema DRGE, com foco nos pontos mais relevantes para provas de Gastroenterologia.